

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬
DNA合成を障害フッ化ピリミジン系 5-FU カペシタビン S-1 FTD/TPI 白金製剤 オキサリプラチン
トポイソメラーゼII阻害薬 イリノテカン血管新生阻害薬
腫瘍血管の新生を阻害抗VEGF抗体 ベバシズマブ 抗VEGFR-2抗体・VEGF捕捉 ラムシルマブ アフリベルセプト ベータ
経口VEGFR阻害薬 レゴラフェニブ フルキンチニブ増殖シグナル阻害薬
EGFR・BRAF・HER2経路を遮断抗EGFR抗体(RAS野生型) セツキシマブ パニツムマブ BRAF/MEK阻害薬 エンコラフェニブ ビニメチニブ
抗HER2抗体 トラスツズマブ ペルツズマブ免疫チェックポイント
阻害薬
MSI-High/dMMRに使用

抗PD-1抗体 ペムブロリズマブ ニボルマブ 抗CTLA-4抗体 イピリムマブ

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 治療ラインの位置づけ(切除不能進行・再発)

対象	1次治療	2次治療	3次治療以降 薬局の出番
RAS野生型 左側原発	● FOLFOX/FOLFIRI+抗EGFR抗体(セツキシマブ/パニツムマブ)	● 1次と異なる化学療法+抗VEGF薬	● レゴラフェニブ ● FTD/TPI±ベバシズマブ ● フルキンチニブ
RAS変異型 または右側原発	● FOLFOX/CAPOX/FOLFIRI(FOLFOXIRI)+ベバシズマブ	● FOLFIRI+ベバシズマブ/ラムシルマブ/アフリベルセプト	● レゴラフェニブ ● FTD/TPI±ベバシズマブ ● フルキンチニブ
BRAF V600E 変異陽性	● FOLFOXIRI+ベバシズマブ 等	● エンコラフェニブ+セツキシマブ(±ビニメチニブ)	● レゴラフェニブ ● FTD/TPI 等
MSI-High dMMR	● ペムブロリズマブ 等(免疫チェックポイント阻害薬)	● 化学療法+分子標的薬	● レゴラフェニブ ● FTD/TPI 等

● 細胞障害性抗がん薬中心 ● 分子標的薬(注射)を含む ● 経口薬を含む ● 免疫チェックポイント阻害薬

HER2陽性(RAS野生型)では化学療法後にトラスツズマブ+ペルツズマブが選択肢。実際の選択は全身状態・前治療・患者の希望をふまえて個別に判断される。

3 副作用の特徴と発現時期

作用機序から予測:抗VEGF薬=血圧・蛋白尿・出血、抗EGFR抗体=皮疹・低Mg血症、イリノテカン=下痢・UGT1A1、オキサリプラチン=しびれ



押さえておきたいポイント

1. 原発部位とRAS・BRAF・MSI・HER2で1次治療が決まり、未使用の薬剤を後のラインで使う
2. 作用機序から副作用を予測:抗VEGF薬=血管系、抗EGFR抗体=皮膚・Mg、イリノテカン=下痢・UGT1A1
3. 経口薬の服用日管理・携帯型ポンプ後のフォロー・Gradeでの共有が薬局の強み